「8ヶ月9部位」は12か月の窓で判定する

結論: 「8ヶ月9部位」は、**判定する月の「前月までの直近12か月」だけを見るルール**です。この「12か月の窓」は毎月1か月ずつ後ろへずれていきます。そのため、ルールどおりに数える限り、月数が12ヶ月を超えて「15ヶ月」「20ヶ月」と増えることは**ありません**（確定：公式の文言から導けます）。古い月は窓から自動的に外れていきます。「治癒したら0に戻る」といったリセットの決まりは、確認できた範囲では**見つかりませんでした**（不明）。数字が下がるのは、施術のない月が続いて古い施術月や部位が窓から外れたときです（推定）。このルールは料金を減らす「逓減」ではありません。**受領委任払いを償還払いへ切り替える候補を選ぶ基準**です。適用は**令和9年（2027年）1月から**で、最初の判定の窓が2026年1月〜12月になるため、「2026年1月からカウント」と言われています（確定）。2026年10月にレセコンが「9ヶ月10部位」と表示しているなら、2026年1〜9月の集計と考えると話が合います（推定）。ただし、2027年に入っても月数が13以上に増え続ける場合は、そのレセコンは窓方式ではなく「2026年1月からの累計」で数えています（推定）。この点はベンダーへの確認が必要です。

> **調査上の注意:** この調査の環境では、厚労省・厚生局・業界団体のサイトに直接アクセスできませんでした（ネットワーク制限）。このため、以下の引用はすべて**検索結果の抜粋や解説記事を経由した二次情報**です。実際に判断する前に、厚労省の疑義解釈資料（事務連絡 令和8年7月1日 PDF）の**問13（数え方）と問16（受領委任の再開）**、それから**7月21日付の一部訂正**（柔整ホットニュース、近畿厚生局）の原文を必ず確認してください。

ラベルの意味 - **【確定】**：公式文言（保険者や団体が引用している文言を含む）から、はっきり言えること - **【推定】**：文言や解説から論理的に導いた内容。公式の明記はまだ確認できていない - **【不明】**：調べた範囲では答えが見つからなかったこと

---

① 現状整理：「8か月以上 かつ 9部位以上」を直近12か月で判定する

ルールの正体

- **【確定】** 公式文言は「令和9年1月以降において、**前月までの連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上**について施術を受けている患者」。保険者が「患者ごとに償還払いへ変更する対象」の例として示しているものです（協会けんぽ、全柔協）。
- **【確定】** 料金改定の施行は令和8年7月1日です。この基準の適用は**令和9年1月以降**です（World-sys、JBA 2517）。
- **【確定】** 疑義解釈の問13では、令和9年1月判定の対象期間を**令和8年1月〜12月**としています（厚労省 事務連絡PDF。抜粋で確認）。「2026年1月からカウント」と言われるのはこのためです（いつき総研）。
- **【確定】** 窓は暦年（1〜12月）で固定されていません。**判定月から12か月さかのぼる**方式で、毎月1か月ずつずれます（JBA 2533）。
- **【確定】** 基準に当てはまっても、**すぐに償還払いになるわけではありません**。流れは「保険者から患者と院へ注意喚起の通知 → 事実確認 → 保険者が個別に判断」です。変更されると、変更通知の翌月以降の施術から償還払いになります（world-hoken、いつき総研）。

- **背景**：部位を次々に変えて請求を続ける「部位転がし」への対策です。健保連の資料には、12か月で負傷4回・12部位・実日数157日という例が載っています（健保連 提出資料）。

別のルールと混同しやすい（ここが混乱の元）

ルール	中身	「8ヶ月9部位」との関係
8ヶ月9部位（令和9年1月〜）	直近12か月で8か月以上かつ9部位以上なら**償還払い変更の候補**	本題
長期逓減（令和8年7月〜）	初検月から**5か月超**で75%、5か月超かつ月10回以上で50%	**別物**。お金が減るルール（厚労省 改定案資料）
2部位目80%逓減（令和8年7月〜）	2部位目80%、3部位目以降60%	**別物**（JBA 2517）
レセプトの「継続月数」欄	長期・頻回の逓減用の月数	**別物**。「リセット」はこちらの話（大黒 コラム）

- **【推定】** 「5か月のうち月10回未満の月があればリセット」という話は**逓減ルール**のものです。8ヶ月9部位にはこの種のリセット規定は見当たりません（大黒 コラム）。

---

② 問題点の特定：月数は12が上限、部位の数え方は未確定

問い1：「12ヶ月10部位 → 15ヶ月 → 20ヶ月」と増えていくのか？

- **【推定（根拠は強い）】 増えません**。窓の長さは12か月で固定なので、「月数」の最大は**12**です。
- **【推定】** レセコンが **13ヶ月以上** と表示したら、そのレセコンは公式基準と違う「2026年1月からの累計」で数えているか、別の欄（継続月数など）を表示しています（World-sys によると、各社は2026年6月時点でまだ開発・準備中でした）。
- **【推定】** 2026年10月時点の「9ヶ月10部位」は、2026年1〜9月の実績と考えると説明がつきます。この時点では累計方式でも窓方式でも同じ数字になるので、**2027年2月以降の表示を見るまで、どちらの方式かは見分けられません**。

問い2：どうなればリセットされるのか？

- **【不明】** 「治癒」「中止」「転医」「◯か月休んだら0に戻る」といった**公式のリセット規定は見つかりませんでした**。
- **【推定】** 0に戻るのではなく、**古い月や部位が窓から外れることで自然に減る**と考えるのが正しい理解です。
- 月数を8未満にするには：直近12か月のうち**施術のない月が5か月以上**あればよい（12−5＝7か月）。
- 部位数が減るのは：その部位を初検した月が窓の外に出たとき（部位を「初検月に1つと数える」解釈の場合）。
- **【確定（要旨のみ）】** 疑義解釈の**問16**：償還払いに変更された後、基準に当てはまらない状態が「一定期間」続けば、保険者は**速やかに受領委任払いに戻す**（全整協 ほか。要旨のみ）。**【不明】** 「一定期間」が何か月かは確認できていません。

- **【推定】** 休んだり部位を変えたりしても逃れられません。保険者側にデータが残り、直近12か月で判定されるためです（note ReKuu）。

問い3（最大の不確定要素）：「9部位」はどう数えるのか

読み方	数え方	例：同じ2部位を5か月通院	出典
A. 新規負傷部位ベース（業界の多数説）	新しく負傷した部位を**初検月に1つ**と数える。続いている部位は重ねて数えない	**2部位** → 非該当	JBA 2533、いつき総研
B. 延べ部位ベース（少数説）	毎月の部位数を足していく	**10部位** → 該当しうる	柔整Masters ③、jitsumu-guide

- **【推定】** 部位転がし対策という目的から考えると、**A（新規負傷部位ベース）が筋の通る解釈**です。ただし公式の原文では確認できていません。
- **【推定】** 治癒した後に同じ部位を再び負傷した場合は、**新しい1部位**として数えるという解説があります（いつき総研）。問13にこの点への言及があることは抜粋で読み取れましたが、肝心の文言は途中で切れていました（**【不明】**）。
- **【不明】** 窓が始まる前に初検し、窓の中でも施術が続いている部位を数えるかどうか。保険者が変わった（転職など）場合に数え直しになるかどうか。複数の院にかかっている場合の扱い。7/21訂正で問13が変わったかどうか。

毎月ずれる窓の具体例（読み方Aで数えた場合）

設定（架空の患者）： 2026年1〜12月は毎月来院。新しく負傷した部位は、1月3部位・3月2部位・6月2部位・9月3部位で、合計10部位。2027年1月以降は来院なし。

判定月	見る期間（窓）	施術月数	部位数（初検月が窓内）	判定
2026年10月（参考表示）	2026/1〜9 ※	9	10	（まだ適用前）レセコン「9ヶ月10部位」と一致
2027年1月	2026/1〜12	12	10	**該当**（8以上・9以上）
2027年2月	2026/2〜2027/1	11	7（1月の3部位が外れる）	非該当（部位が足りない）
2027年5月	2026/5〜2027/4	8	5	非該当
2027年6月	2026/6〜2027/5	7	5	非該当（月数も8未満）

※ 2025年以前の施術がない前提です。 - **ポイント1**：月数は「12」が上限です。2027年2月以降は、新しい来院がなければ**減っていきます**。 - **ポイント2**：読み方B（延べ）で数えると、2027年2月も部位数が9以上

のまま「該当」になる可能性があります。**読み方によって結果が変わります（【不明】）。** - **ポイント3**：もし2027年2月にレセコンが「13ヶ月」と表示したら、それは累計方式です（**【推定】**）。

---

③ 改善案（複数）

- **案1：レセコンのベンダーに数え方を確認する**（下の質問リストを使う）
- **案2：院内で「直近12か月チェック表」を毎月つける**（下の手順）
- **案3：一次資料を入手して読む**：疑義解釈の問13・問16と7/21訂正。厚生局のサイト、または所属団体（全柔協・日整・各県の柔整師会など）から入手する
- **案4：所属団体に「部位の数え方（新規か延べか）」を照会する**
- **案5：該当しそうな患者の記録を整える**：負傷原因・初検日・治癒日・施術計画をきちんと残し、保険者からの事実確認に答えられるようにする。**数字を基準より下に見せるために来院や部位の記録を操作するのは不正請求のリスクがあり、絶対に行わないこと**

実務用セルフチェック手順（毎月、月初に5分）

1. **判定月を決める**（例：2027年3月）。
2. **窓を出す**：判定月の**12か月前〜前月**（例：2026年3月〜2027年2月）。
3. **月数を数える**：窓の中で、施術が1日でもあった月の数を数える → **8以上か？**（**【不明】** 1日でも数えるのか、レセプトを出した月で数えるのかは未確認。おそらくどちらも同じ結果）
4. **部位数を数える**：窓の中で**初検した**負傷部位の数を数える（読み方A） → **9以上か？** 念のため延べでも数えておく（読み方B）。
5. **両方とも以上なら「該当候補」**、片方だけなら非該当。
6. **早めの注意**：**7か月 または 8部位** に達したら「接近」として印をつける（本報告の提案。公式の基準ではありません）。
7. **レセコンと突き合わせる**：レセコンの表示と自分の手計算がずれていたら、ベンダーに問い合わせる。

レセコンのベンダーへの質問リスト

1. 表示されている「◯ヶ月◯部位」は、**判定月の前月までの直近12か月**の数ですか？ それとも**2026年1月からの累計**ですか？
2. 表示の基準になっている「判定月」はどの月ですか？（当月ですか、翌月ですか）
3. 2027年以降、月数が**12を超えて表示されることはありますか？**
4. 部位は**新規負傷部位を初検月に1つ**と数えていますか？ それとも**毎月の延べ**ですか？
5. **治癒した後に同じ部位を再び負傷**した場合、数え直していますか？
6. **窓が始まる前に初検した部位**で、窓の中でも続いているものは数えていますか？
7. **保険者が変わった**患者の過去分は、合算していますか？ 分けていますか？
8. この表示はレセプトの「**継続月数**」欄（逓減用）とは別のものですか？
9. 疑義解釈の**問13と7/21訂正**を反映済みですか？ 反映した日はいつですか？
10. 該当候補・接近患者を**一覧で出す機能**はありますか？（ボンズメディカルのように抽出マニュアルを出している会社もあります：ボンズメディカル）

---

④ メリット・デメリット

案	メリット	デメリット・リスク
1. ベンダー確認	手間が少ない。表示の意味が一度で確定する	ベンダー自身が開発中で、答えが曖昧な可能性がある
2. 院内チェック表	レセコンに頼らず自分で判断できる。接近患者に早く気づける	毎月の作業が増える。部位の数え方が未確定なので、AとBの2通りで数える必要がある
3. 一次資料を読む	最も確実。7/21訂正も含めて確認できる	役所の文章は読みにくい。入手に手間がかかる
4. 団体に照会	解釈の不明点を専門家に聞ける	返事に時間がかかる。団体によって見解が違うことがある
5. 記録の整備	保険者の事実確認に強くなる。正当な施術を守れる	記録の作業が増える

全体のリスク - **数え方を誤解するリスク**：累計表示をそのまま信じると、該当しない患者まで「危ない」と判断してしまう（過剰に心配する）。延べと新規を取り違えると、逆に見逃してしまう。 - **償還払いになったときの影響**：患者は窓口で全額を払ってから保険者に請求することになり、負担が増えて**通院をやめるリスク**があります。院側も受領委任の収入が減ります（**【推定】**）。 - **情報の確度のリスク**：この報告は二次情報に基づいています。原文で結論が変わる可能性があります。

---

⑤ 優先順位

順位	やること	期限の目安	理由
1	案1：ベンダーに質問リストを送る	2026年11月中	最初の判定（2027年1月、窓は2026年1〜12月）まで時間がない
2	案3＋4：問13・問16・7/21訂正を入手し、部位の数え方を団体に確認する	2026年11〜12月	「新規か延べか」で該当者が大きく変わるため
3	案2：保険患者全員を直近12か月で手計算し、「接近（7か月または8部位）」の患者に印をつける	2026年12月	2027年1月の判定で該当しそうな人を事前に把握する
4	案5：接近患者の初検日・負傷原因・治癒日の記録を見直す	2027年1月以降、毎月	保険者からの注意喚起に正しく答えるため

結論

このルールは「長く通ったら罰」ではありません。**「直近1年に、たくさんの部位を、長い期間」という組み合わせに当てはまる人を選び出すための網**です。月数には12という上限があり、窓が毎月ずれるので、「リセット」を待つ必要はありません。来院や新しい負傷がなくなれば、数字は自然に下がっていきます。本当に気をつけるべきなのは月数ではなく、**部位をどう数えるか（新規か延べか）**と、**自分のレセコンが窓**

方式か累計方式かの2点です。この2点は、2027年2月の表示が12を超えるかどうかで見分けがつきます。ただ、それを待たずに、ベンダーと一次資料で11〜12月中に確定させておくのが安全です。